PRÜFUNGSTRAINING · VERTIEFUNG LANGZEITPFLEGE

Langzeitpflege & ambulante Pflege

Prüfungsfragen mit Erklärungen für den Vertiefungseinsatz im Pflegeheim und in der häuslichen Pflege – von Pflegegraden bis Palliativversorgung.

Bestehen ist planbar.

SGB XI · Expertenstandards · Demenz · Fallbeispiele

77	16	A4
Fragen	Themenbereiche	druckfertig

INHALT

1. Pflegegrade & Begutachtung
2. Leistungen der Pflegeversicherung
3. Strukturmodell & SIS
4. Qualität & Heimrecht NRW
5. Expertenstandards
6. Demenz & Delir
7. Recht: FEM, Vorsorge, Verfügung
8. Geriatrie
9. Ernährung
10. … und 7 weitere Bereiche

⚠ Lernhilfe, mit KI-Unterstützung erstellt und fachlich geprüft. Maßgeblich sind Lehrinhalte, Leitlinien und Standards deiner Einrichtung.

Patrick Schenkelberger · Fachpfleger Anästhesie & Intensivmedizin, Praxisanleiter

plan-nrw.de

So nutzt du das Heft

Beantworte die Fragen eines Bereichs, kontrolliere dann im Lösungsteil. Falsche Antworten markieren und nach ein paar Tagen wiederholen. Rechtsstand Pflegeversicherung: Oktober 2026.

SCHWIERIGKEIT

● leicht · ●● mittel · ●●● schwer

EHRLICH TESTEN

Lösungen und Erklärungen stehen gesammelt am Ende – kein Spoiler beim Lernen.

THEMENBEREICHE

01 Pflegegrade & Begutachtung · 5 Fragen
02 Leistungen der Pflegeversicherung · 7 Fragen
03 Strukturmodell & SIS · 3 Fragen
04 Qualität & Heimrecht NRW · 4 Fragen
05 Expertenstandards · 6 Fragen
06 Demenz & Delir · 5 Fragen
07 Recht: FEM, Vorsorge, Verfügung · 3 Fragen
08 Geriatrie · 11 Fragen
09 Ernährung · 4 Fragen
10 Haut & Dekubitus · 3 Fragen
11 Palliativ & Sterbephase · 4 Fragen
12 Ambulante Pflege · 7 Fragen
13 Mobilität · 3 Fragen
14 Kommunikation & Ethik · 3 Fragen
15 Hygiene · 3 Fragen
16 Fallbeispiele · 6 Fragen

© PLAN Digital · Patrick Schenkelberger. Nur für den persönlichen Gebrauch. Weitergabe, Weiterverkauf und Veröffentlichung nicht gestattet.

1 Pflegegrade & Begutachtung

5 Fragen

1 **Wie viele Pflegegrade kennt die Pflegeversicherung (SGB XI)?**

- A 5 Pflegegrade
- B 3 Pflegestufen
- C 6 Pflegegrade
- D 4 Pflegegrade

2 **Welches der 6 Module des Neuen Begutachtungsassessments (NBA) wird mit 40 % am stärksten gewichtet?**

- A Alltagsleben und soziale Kontakte
- B Mobilität
- C Kognitive und kommunikative Fähigkeiten
- D Selbstversorgung

3 **Ab wie vielen Gesamtpunkten im NBA liegt Pflegegrad 3 vor?**

- A Ab 12,5 Punkten
- B Ab 27 Punkten
- C Ab 47,5 Punkten
- D Ab 70 Punkten

4 **Wer führt bei gesetzlich Versicherten in der Regel die Begutachtung zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit durch?**

- A Die Pflegedienstleitung im Auftrag des Trägers
- B Die behandelnde Hausärztin im Auftrag der Krankenkasse
- C Die Heimaufsicht im Auftrag der Kommune
- D Der Medizinische Dienst im Auftrag der Pflegekasse

5 **Was wird im NBA-Modul 'Mobilität' beurteilt?**

- A Einkäufe, Behördengänge und Fahrten zu Arztterminen außer Haus
- B Positionswechsel, Sitzen, Umsetzen und Fortbewegen in der Wohnung
- C Richten und Einnehmen der Medikamente
- D Orientierung zu Ort, Zeit und Personen

2 Leistungen der Pflegeversicherung

7 Fragen

6 **Welche Leistung rechnet ein ambulanter Pflegedienst für die Körperpflege bei der Pflegekasse ab?**

- A Pflegegeld nach § 37 SGB XI
- B Verhinderungspflege nach § 39 SGB XI
- C Häusliche Krankenpflege nach § 37 SGB V
- D Pflegesachleistung nach § 36 SGB XI

7 **Wer verordnet häusliche Krankenpflege, etwa Insulininjektionen oder Wundversorgung?**

- A Die Pflegefachkraft, die Pflegekasse genehmigt
- B Die Pflegedienstleitung nach Erstbesuch
- C Die Ärztin, die Krankenkasse genehmigt
- D Der Medizinische Dienst nach Begutachtung

8 **Wie oft müssen Pflegebedürftige mit Pflegegrad 4 oder 5, die nur Pflegegeld beziehen, einen Beratungsbesuch abrufen?**

(A) Einmal im Kalenderjahr
(B) Halbjährlich
(C) Einmal im Jahr
(D) Vierteljährlich

9 **Wofür kann der Entlastungsbetrag nach § 45b SGB XI genutzt werden?**

(A) Für anerkannte Angebote zur Unterstützung im Alltag
(B) Für den Eigenanteil im Pflegeheim
(C) Für ärztlich verordnete Medikamente und Verbandmittel aus der Apotheke
(D) Als Bargeld zur freien Verfügung

10 **Was unterscheidet Tagespflege von Kurzzeitpflege?**

(A) Beide sind ambulante Leistungen, Tagespflege ist aber nur an Wochenenden und Feiertagen möglich
(B) Tagespflege ist tagsüber mit Rückkehr nach Hause, Kurzzeitpflege vorübergehend vollstationär
(C) Tagespflege ist vorübergehend vollstationär, Kurzzeitpflege nur stundenweise zu Hause
(D) Beide sind vollstationär, Kurzzeitpflege aber nur nach einer Operation

11 **Was bezuschusst die Pflegekasse als 'Maßnahme zur Verbesserung des Wohnumfeldes'?**

(A) Die Umzugskosten ins Pflegeheim
(B) Neue Möbel nach eigenem Geschmack
(C) Die regelmäßige Reinigung der Wohnung
(D) Umbauten wie eine bodengleiche Dusche

12 **Welche Aufgabe haben kostenlose Pflegekurse für Angehörige (§ 45 SGB XI)?**

(A) Die Begutachtung des MD ersetzen
(B) Die Höhe des Pflegegeldes festlegen
(C) Angehörige schulen und entlasten
(D) Angehörige zur Fachkraft ausbilden

3 Strukturmodell & SIS

3 Fragen

13 **Womit beginnt die Pflegedokumentation nach dem Strukturmodell?**

(A) Mit der Strukturierten Informationssammlung (SIS)
(B) Mit dem täglich abgezeichneten Leistungsnachweis der Tour
(C) Mit dem ärztlichen Medikationsplan
(D) Mit einer Pflegeanamnese nach AEDL

14 **Was wird in der Risikomatrix der SIS eingeschätzt?**

(A) Die Belastung der pflegenden Angehörigen
(B) Wechselwirkungen und Nebenwirkungen aller aktuellen Medikamente
(C) Pflegesensitive Risiken wie Dekubitus, Sturz oder Schmerz
(D) Die Kosten der geplanten Maßnahmen

15 **Was wird im Berichteblatt nach dem Strukturmodell dokumentiert?**

(A) Die täglichen Vitalwerte aller Bewohner

(B) Abweichungen von der Planung und aktuelle Ereignisse

(C) Jede routinemäßig erbrachte Grundpflege

(D) Ausschließlich die ärztlichen Anordnungen und deren Uhrzeiten

4 Qualität & Heimrecht NRW

4 Fragen

16 **Wer prüft die Qualität in Pflegeheimen im Auftrag der Pflegekassen?**

(A) Das Gesundheitsamt im Auftrag des Landes

(B) Die Berufsgenossenschaft im Auftrag des Trägers

(C) Der Medizinische Dienst bzw. der PKV-Prüfdienst

(D) Die Pflegekammer im Auftrag der Kassen

17 **Was sind Qualitätsindikatoren in der vollstationären Langzeitpflege?**

(A) Monatlich erhobene Umfragen zur Zufriedenheit der Angehörigen

(B) Halbjährlich erhobene Ergebnisdaten, z. B. Dekubitusentstehung

(C) Quartalsweise erhobene Kosten pro Bewohner

(D) Jährlich gemeldete Personalzahlen und Fachkraftquoten

18 **Was ist das Ziel einer Pflegevisite?**

(A) Die ärztliche Visite im Heim ersetzen

(B) Die Pflege mit der Person überprüfen und anpassen

(C) Die Arbeit der Pflegekräfte heimlich kontrollieren

(D) Das Zimmer auf Ordnung und Sauberkeit prüfen

19 **Welches Landesgesetz regelt in NRW Anforderungen an Pflegeheime (Heimrecht)?**

(A) Das Wohn- und Teilhabegesetz (WTG NRW)

(B) Das Heimgesetz des Bundes in der Fassung von 1974

(C) Das Pflegeberufegesetz (PflBG)

(D) Das Landespflegegesetz Berlin

5 Expertenstandards

6 Fragen

20 **Wer gibt in Deutschland die Expertenstandards in der Pflege heraus?**

(A) Das Robert Koch-Institut

(B) Die Bundesärztekammer

(C) Der Medizinische Dienst

(D) Das DNQP

21 **Was ist nach dem Expertenstandard Sturzprophylaxe der erste Schritt?** ●●

(A) Gehstrecken für Risikopersonen einschränken
(B) Individuelle Einschätzung der Sturzrisikofaktoren
(C) Sturzrisiko mit einer festen Punkteskala berechnen
(D) Bettgitter bei allen Risikopersonen hochstellen

22 **Was ist ein Hauptziel des Expertenstandards 'Beziehungsgestaltung in der Pflege von Menschen mit Demenz'?** ●●

(A) Das Gefühl stärken, gehört und angenommen zu werden
(B) Unruhiges Verhalten schnell medikamentös dämpfen
(C) Die Person konsequent und geduldig an die Realität heranführen
(D) Den Tagesablauf streng nach Plan strukturieren

23 **Was passt zum Expertenstandard 'Erhaltung und Förderung der Mobilität'?** ●●

(A) Für längere Strecken immer den Rollstuhl nutzen
(B) Mobilität gezielt in Alltagsaktivitäten fördern
(C) Bettruhe zur Schonung alter Menschen fördern
(D) Mobilität nur in der Physiotherapie trainieren

24 **Was ist Ziel des Expertenstandards 'Förderung der Harnkontinenz'?** ●●

(A) Alle Bewohner mit Vorlagen versorgen
(B) Die Trinkmenge abends deutlich reduzieren, um Nässe zu vermeiden
(C) Kontinenz fördern oder Inkontinenz gut kompensieren
(D) Frühzeitig einen Dauerkatheter legen

25 **Eine Person versorgt ihre Inkontinenz selbstständig mit Vorlagen, Außenstehende bemerken nichts. Welches Kontinenzprofil liegt vor?** ●●●

(A) Abhängig erreichte Kontinenz
(B) Unabhängig kompensierte Inkontinenz
(C) Abhängig kompensierte Inkontinenz mit Hilfe
(D) Unabhängig erreichte Kontinenz

6 Demenz & Delir

5 Fragen

26 **Was ist das Grundprinzip der Validation nach Naomi Feil?** ●

(A) Falsche Aussagen freundlich, aber konsequent korrigieren
(B) Die Person freundlich ablenken, ohne auf das Gesagte einzugehen
(C) Gefühle wertschätzen statt mit der Realität konfrontieren
(D) Täglich Datum, Ort und Namen gemeinsam einüben

27 **Eine Bewohnerin mit Demenz will abends 'nach Hause zu den Kindern'. Wie reagierst du am besten?** ●●

A Das Gefühl aufgreifen und über ihre Kinder sprechen

B Die Tür verschließen, damit sie nicht wegläuft

C Ruhig erklären, dass ihre Kinder längst erwachsen sind

D Ihr sagen, dass sie hier jetzt ihr Zuhause hat

28 **Was beschreibt das NDB-Modell (Need-driven Dementia-compromised Behavior)?** ●●

A Ein Stufenschema für Medikamente gegen Unruhe

B Eine Skala zur Einschätzung der Weglaufgefahr

C Herausforderndes Verhalten als Ausdruck unerfüllter Bedürfnisse

D Demenz als zwangsläufige und unbeeinflussbare Folge des normalen Alterns

29 **Welches Instrument dient der Schmerzeinschätzung bei fortgeschrittener Demenz?** ●●●

A Barthel-Index

B Braden-Skala

C BESD

D NRS

30 **Woran erkennst du am ehesten ein Delir im Unterschied zur Demenz?** ●●

A Schleichender Beginn über mehrere Jahre mit langsamem Fortschreiten

B Plötzlicher Beginn mit schwankender Aufmerksamkeit

C Stabile Aufmerksamkeit über den Tag

D Kein Zusammenhang mit Infekten oder Medikamenten

7 Recht: FEM, Vorsorge, Verfügung

3 Fragen

31 **Ein einwilligungsunfähiger Bewohner soll durch ein Bettgitter am Aufstehen gehindert werden. Was ist nötig?** ●●

A Eine Anordnung der Pflegefachkraft im Nachtdienst

B Einwilligung des Betreuers und Genehmigung des Betreuungsgerichts

C Die mündliche Zustimmung der Angehörigen

D Eine schriftliche Anordnung des Hausarztes

32 **Welche Alternative zum Bettgitter beugt Sturzfolgen vor, ohne die Freiheit einzuschränken?** ●●

A Niedrigflurbett mit Sturzmatte

B Abschließen des Zimmers

C Schlafmittel am Abend

D Bauchgurt im Bett für die Nacht

33 **Was ist eine Vorsorgevollmacht?**

- A Eine ärztliche Verordnung für häusliche Pflege
- B Ein Antrag bei der Pflegekasse auf einen höheren Pflegegrad
- C Eine Vertrauensperson wird bevollmächtigt, zu entscheiden
- D Eine Verfügung über das Erbe nach dem Tod

8 Geriatrie

11 Fragen

34 **Warum sind ältere Menschen besonders gefährdet für eine Exsikkose?**

- A Der Wasseranteil des Körpers steigt an
- B Ältere Menschen schwitzen kaum noch
- C Die Nieren speichern im Alter mehr Wasser
- D Das Durstgefühl lässt im Alter nach

35 **Welche Zeichen sprechen bei einer alten Person am ehesten für eine Exsikkose?**

- A Gesteigerter Appetit, Unruhe, Durchfall und gerötete Wangen
- B Akute Verwirrtheit, trockene Mundschleimhaut, dunkler Urin
- C Feuchte Zunge, heller Urin und guter Hautturgor
- D Beinödeme, Gewichtszunahme und Atemnot im Liegen

36 **Wie viel Flüssigkeit benötigt ein älterer Mensch als grobe Orientierung pro Tag, wenn keine ärztliche Begrenzung besteht?**

- A Etwa 10 ml pro kg Körpergewicht
- B Nur so viel, wie der Durst verlangt
- C Mindestens 60 ml pro kg Körpergewicht
- D Etwa 30 ml pro kg Körpergewicht

37 **Was ist die PRISCUS-Liste?**

- A Eine Liste meldepflichtiger Infektionskrankheiten
- B Eine Liste potenziell ungeeigneter Medikamente im Alter
- C Eine Liste zur Einstufung von Pflegegraden
- D Eine Liste der von der Pflegekasse bezahlten Hilfsmittel

38 **Ab wie vielen dauerhaft eingenommenen Medikamenten spricht man üblicherweise von Polypharmazie?**

- A Ab 10 Wirkstoffen
- B Ab 2 Wirkstoffen
- C Ab 5 Wirkstoffen
- D Ab 15 Wirkstoffen

39 **Was beschreibt der Begriff 'Frailty' (Gebrechlichkeit)?**

- A Eine frühe Form der vaskulären Demenz
- B Eine akute bakterielle Infektion bei alten Menschen
- C Verminderte körperliche Reserve mit Schwäche und Gewichtsverlust
- D Eine chronische Hauterkrankung im hohen Alter

40 **Welche Inkontinenzform liegt vor, wenn beim Husten oder Niesen Urin verloren geht?** ●●

- A Neurogene Reflexinkontinenz
- B Dranginkontinenz
- C Überlaufinkontinenz
- D Belastungsinkontinenz

41 **Ein Bewohner verliert ständig tröpfchenweise Urin, die Blase ist prall tastbar. Woran denkst du?** ●●●

- A Belastungsinkontinenz, Beckenboden trainieren
- B Dranginkontinenz, Trinkmenge reduzieren
- C Funktionelle Inkontinenz, Toilette markieren
- D Überlaufinkontinenz, ärztlich abklären lassen

42 **Welche Maßnahme beugt einer Obstipation im Alter vor?** ●

- A Weißbrot, Zwieback und Bananen bevorzugen
- B Trinken, Ballaststoffe und Bewegung
- C Wenig trinken und viel liegen
- D Täglich Abführmittel auf Vorrat

43 **Welches Warnzeichen spricht bei einer Bewohnerin für eine Schluckstörung (Dysphagie)?** ●●

- A Vorliebe für süße und weiche Speisen
- B Großer Durst nach salzigen Speisen
- C Häufiges Gähnen nach dem Mittagessen
- D Husten beim Essen und eine gurgelnde Stimme danach

44 **Was ist Sarkopenie?** ●●

- A Altersbedingter Verlust von Hautelastizität
- B Altersbedingter Verlust von Nervenzellen im Rückenmark
- C Altersbedingter Verlust von Muskelmasse und -kraft
- D Altersbedingter Verlust von Knochendichte

9 Ernährung

4 Fragen

45 **Welches Instrument dient dem Screening auf Mangelernährung bei älteren Menschen?** ●●

- A Mini Nutritional Assessment (MNA)
- B Mini-Mental-Status-Test (MMST)
- C Geriatrische Depressionsskala (GDS)
- D Norton-Skala

46 **Was ist ein Warnsignal für Mangelernährung?** ●●

- A Eine leichte Gewichtszunahme von 1 kg innerhalb von 6 Monaten
- B Ungewollt mehr als 5 % Gewichtsverlust in 3 Monaten
- C Wunsch nach kleineren, häufigeren Mahlzeiten
- D Ein stabiler BMI von 24 seit einem Jahr

47 **Was hilft Menschen mit Demenz, die beim Essen nicht ruhig sitzen bleiben?**

- A Mahlzeiten nur noch im Bett anbieten
- B Den Stuhl näher an den Tisch fixieren
- C Fingerfood, das im Gehen gegessen werden kann
- D Ganz auf hochkalorische Trinknahrung umstellen

48 **Was gilt bei fortgeschrittener Demenz zur PEG-Sonde laut Leitlinien?**

- A Immer empfohlen, weil sie das Leben deutlich verlängert
- B Pflicht ab Pflegegrad 4 bei Gewichtsverlust
- C Frühzeitig empfohlen, um Aspirationen sicher zu verhindern
- D Nicht routinemäßig empfohlen; Wille der Person entscheidet

10 Haut & Dekubitus

3 Fragen

49 **Woran erkennst du einen Dekubitus Kategorie 1?**

- A Rötung bleibt bei Fingerdruck bestehen
- B Haut ist oberflächlich offen und nässt leicht
- C Rötung verschwindet bei Fingerdruck
- D Es bildet sich eine Blase mit Sekret

50 **Was ist bei einer Inkontinenz-assoziierten Dermatitis (IAD) typisch?**

- A Schwarze Nekrose an der Ferse durch Druck
- B Tiefe, scharf begrenzte Wunde über dem Kreuzbein durch Druck
- C Kreisrunde Rötung am Trochanter durch Reibung
- D Flächige Rötung im Intimbereich durch Feuchtigkeit

51 **Welche Hautpflege eignet sich bei trockener Altershaut?**

- A Rückfettende Wasser-in-Öl-Produkte, lauwarm waschen
- B Einreiben mit Franzbranntwein zur Durchblutung
- C Häufiges Waschen mit heißem Wasser und Seife
- D Regelmäßig Puder auftragen, damit die Haut schön trocken bleibt

11 Palliativ & Sterbephase

4 Fragen

52 **Was ist die SAPV?**

- A Eine Pflegegeldleistung für Sterbende zu Hause
- B Ein ehrenamtlicher Hospizdienst ohne Fachpersonal
- C Eine stationäre Palliativstation im Krankenhaus
- D Spezialisierte ambulante Palliativversorgung, auch im Pflegeheim

53 **Welche Zeichen sprechen für die Sterbephase?**

(A) Zunehmende Schläfrigkeit, Rasselatmung, marmorierte Haut
(B) Hoher Blutdruck, gerötetes Gesicht und starkes Schwitzen
(C) Zunehmende Unruhe, Fieber und Durchfall
(D) Steigender Appetit, mehr Durst und rosige Haut

54 **Was lindert Mundtrockenheit in der Sterbephase am besten?**

(A) Mundpflege mit Lieblingsgetränken
(B) Zitronenglycerinstäbchen mehrmals täglich
(C) Infusionen mit viel Flüssigkeit
(D) Den Mund mit Gaze verschließen

55 **Was bedeutet 'palliativ'?**

(A) Lindernd, wenn Heilung nicht mehr möglich ist
(B) Rehabilitierend nach einer Operation
(C) Vorbeugend, bevor eine Erkrankung überhaupt beginnt
(D) Heilend durch maximale Therapie

12 Ambulante Pflege

7 Fragen

56 **Du findest einen Patienten bei der Tour gestürzt auf dem Boden. Was tust du zuerst?**

(A) Ansprechen und Zustand nach ABCDE prüfen
(B) Den Patienten zügig zurück ins Bett heben
(C) Zuerst die Angehörigen telefonisch informieren
(D) Den Sturz im Tourenplan dokumentieren

57 **Was ist ein Hausnotruf?**

(A) Die bundesweit einheitliche Notrufnummer 112 für Rettungsdienst
(B) Ein Alarmsystem gegen Einbrecher
(C) Ein Rufsystem in Krankenhauszimmern
(D) Ein Gerät, um per Knopfdruck Hilfe zu rufen

58 **Was gilt für die Hygiene in der häuslichen Pflege?**

(A) Desinfektionsmittel des Patienten mitbenutzen
(B) Ein Paar Handschuhe für die ganze Tour tragen
(C) Händedesinfektion wie in der Klinik und eigene Schutzausrüstung
(D) In der Wohnung reicht gelegentliches Händewaschen

59 **Was gilt beim Stellen von Medikamenten in der ambulanten Pflege?**

(A) Nur nach ärztlicher Verordnung laut Medikationsplan
(B) Nach den Dosierungsangaben auf dem jeweiligen Beipackzettel
(C) Nach eigener Einschätzung der Pflegefachkraft
(D) Nach Absprache mit den pflegenden Angehörigen

60 **Ein Patient lehnt die geplante Körperpflege heute ab. Wie gehst du vor?** ●●

(A) Pflege trotzdem zügig und freundlich durchführen

(B) Einsatz streichen, ohne ihn zu dokumentieren

(C) Wunsch respektieren, Gründe erfragen, dokumentieren

(D) Angehörige anrufen und sie über die Pflege entscheiden lassen

61 **Woran erkennst du eine Überlastung pflegender Angehöriger?** ●●

(A) Mehr Geduld, gute Laune und häufigere gemeinsame Ausflüge

(B) Erschöpfung, Gereiztheit und sozialer Rückzug

(C) Regelmäßiger Urlaub und viele Freunde

(D) Steigendes Interesse an Hobbys

62 **Bei einem Einsatz siehst du Hämatome unterschiedlichen Alters an den Oberarmen einer verängstigten alten Dame. Was tust du?** ●●●

(A) Die Angehörigen beim nächsten Besuch direkt zur Rede stellen

(B) Nichts sagen, weil es eine Familienangelegenheit ist

(C) Mit Salbe versorgen und nicht weiter beachten

(D) Sachlich dokumentieren und mit der Leitung besprechen

13 Mobilität

3 Fragen

63 **Was ist das Ziel der Kinästhetik in der Pflege?** ●

(A) Bewegungsfähigkeit der Person nutzen statt heben

(B) Muskeln und Gelenke durch möglichst wenig Bewegung schonen

(C) Jeden Transfer nur mit Lifter durchführen

(D) Patienten möglichst schnell und sicher tragen

64 **Welche Hilfsmittel unterstützen den Transfer vom Bett in den Rollstuhl rückenschonend?** ●●

(A) Achselgriff mit zwei Pflegenden

(B) Ein Küchenstuhl als Zwischenstation

(C) Rutschbrett, Drehscheibe oder Lifter

(D) Bettlaken zum Ziehen auf die Bettkante

65 **Was ist eine Kontraktur?** ●●

(A) Dauerhafte Bewegungseinschränkung eines Gelenks

(B) Kurzer Muskelkrampf für wenige Sekunden

(C) Knöcherner Bruch nahe einem Gelenk

(D) Entzündliche Rötung über einem Gelenk

14 Kommunikation & Ethik

3 Fragen

66 **Wie sprichst du am besten mit einem schwerhörigen Bewohner?**

- A Nur noch schriftlich mit ihm reden
- B Von hinten laut ins bessere Ohr rufen
- C Schnell und ohne Pausen sprechen, damit er dranbleibt
- D Von vorne, langsam und deutlich sprechen

67 **Warum sollte man 'Elderspeak' vermeiden?**

- A Fachbegriffe sind für Ältere zu kompliziert
- B Verniedlichende Sprache wirkt entwürdigend
- C Dialekt wird von Älteren nicht verstanden
- D Langsames Sprechen überfordert ältere Menschen

68 **Was steht bei einer ethischen Fallbesprechung im Mittelpunkt?**

- A Die rechtliche Absicherung der Einrichtung
- B Die Wünsche der Angehörigen, die am häufigsten zu Besuch kommen
- C Der (mutmaßliche) Wille der betroffenen Person
- D Die Meinung der erfahrensten Pflegekraft

15 Hygiene

3 Fragen

69 **Ein Bewohner ist mit MRSA besiedelt. Was gilt in der Regel im Pflegeheim?**

- A Sofortige Verlegung in ein Krankenhaus
- B Dauerhafte Isolation im Einzelzimmer ohne Besuch
- C Basishygiene, Schutzkittel bei engem Kontakt, Teilhabe möglich
- D Keine Maßnahmen, weil MRSA nur Kliniken betrifft

70 **Mehrere Bewohner haben im Winter gleichzeitig Durchfall und Erbrechen. Woran denkst du zuerst?**

- A Nebenwirkung von Abführmitteln, absetzen
- B Norovirus-Ausbruch, Hygiene verschärfen und melden
- C Lebensmittelallergie, Speiseplan umstellen
- D Zu kalte Getränke, warmen Tee anbieten

71 **Welche Impfung wird Bewohnern von Pflegeheimen jährlich im Herbst empfohlen?**

- A Tetanus
- B Influenza (Grippe)
- C Hepatitis A
- D Masern-Mumps-Röteln (MMR)

16 Fallbeispiele

6 Fragen

72 **Fall: Frau K., 86 J., lebt allein. Sie trinkt kaum, ist seit gestern verwirrt, die Zunge ist trocken. Was ist dein wichtigster nächster Schritt?** ●●

A Die Tochter bitten, heute Abend vorbeizuschauen

B Bis zum nächsten Einsatz abwarten und beobachten

C Vitalzeichen erheben, Arzt informieren, Trinken anbieten

D Ein pflanzliches Beruhigungsmittel anbieten

73 **Fall: Herr B., 79 J., stürzt im Heim zum dritten Mal, meist nachts auf dem Weg zur Toilette. Was ist am sinnvollsten?** ●●

A Ursachen klären, Nachtlicht und rutschfeste Schuhe

B Ihn nachts mit einer Vorlage im Bett lassen

C Abends nichts mehr zu trinken geben

D Bettgitter nachts hochziehen, damit er liegen bleibt

74 **Fall: Frau S., 91 J., fortgeschrittene Demenz, isst seit Tagen kaum noch. Die Tochter fordert eine PEG. Was ist fachlich richtig?** ●●●

A Sofort eine PEG organisieren, weil die Tochter es wünscht

B Mutmaßlichen Willen klären, ethische Fallbesprechung anregen

C Die Tochter auf den Hausarzt verweisen und selbst nichts weiter unternehmen

D Hochkalorische Trinknahrung notfalls mit Druck geben

75 **Fall: Ein Patient mit Diabetes zeigt dir eine schmerzlose, schwarze Stelle an der Ferse. Was tust du?** ●●

A Warme Fußbäder zur Durchblutung empfehlen

B Die schwarze Stelle vorsichtig selbst abtragen

C Mit einem Pflaster abdecken und beim nächsten Mal ansehen

D Druck entlasten, dokumentieren, zeitnah ärztlich abklären

76 **Fall: Frau T. pflegt ihren Mann (Pflegegrad 2) und sagt: 'Ich kann nicht mehr.' Was empfiehlst du?** ●●

A Entlastung erklären, z. B. Tagespflege und Pflegeberatung

B Ihr Mut machen, dass es bald besser wird

C Sofort einen Heimplatz für ihren Mann beantragen

D Das als Privatsache betrachten und nicht ansprechen

77 **Fall: Eine Bewohnerin mit Parkinson erhält L-Dopa unregelmäßig und wird zunehmend steif. Was ist wichtig?** ●●●

A Tabletten bei Steifigkeit vorübergehend weglassen

B Pünktlich geben, Eiweiß zeitversetzt, Arzt informieren

C Tablette zum eiweißreichen Frühstück mit Milch geben

D Dosis bei zunehmender Steifigkeit eigenständig etwas erhöhen

Lösungsschlüssel & Erklärungen

Richtige Antwort und kurze Begründung zu jeder Frage.

Pflegegrade & Begutachtung

1 **A** Seit 2017 gibt es 5 Pflegegrade (§ 15 SGB XI). Sie haben die früheren 3 Pflegestufen abgelöst. Grundlage ist das Neue Begutachtungsassessment (NBA).

2 **D** Gewichtung: Mobilität 10 %, kognitive/kommunikative Fähigkeiten bzw. Verhaltensweisen 15 % (der höhere Wert zählt), Selbstversorgung 40 %, Umgang mit krankheits-/therapiebedingten Anforderungen 20 %, Alltagsleben und soziale Kontakte 15 %.

3 **C** PG 1: ab 12,5 · PG 2: ab 27 · PG 3: ab 47,5 · PG 4: ab 70 · PG 5: ab 90 Punkten (bis 100). Grundlage: § 15 SGB XI.

4 **D** Die Pflegekasse beauftragt den Medizinischen Dienst (bei Privatversicherten: Medicproof). Der Gutachter erfasst die Selbstständigkeit mit dem NBA.

5 **B** Modul 1 Mobilität umfasst 5 Kriterien: Positionswechsel im Bett, stabile Sitzposition, Umsetzen, Fortbewegen innerhalb des Wohnbereichs und Treppensteigen. Außerhäusliche Aktivitäten fließen nicht in den Pflegegrad ein.

Leistungen der Pflegeversicherung

6 **D** Pflegesachleistungen sind körperbezogene Pflege, Betreuung und Hilfen im Haushalt durch einen zugelassenen Dienst. Pflegegeld erhalten Pflegebedürftige, die ihre Pflege selbst (z. B. durch Angehörige) sicherstellen. Häusliche Krankenpflege betrifft Behandlungspflege.

7 **C** Behandlungspflege ist eine ärztlich verordnete Leistung nach § 37 SGB V und wird von der Krankenkasse genehmigt – unabhängig vom Pflegegrad.

8 **D** Nach § 37 Abs. 3 SGB XI: Pflegegrad 2 und 3 halbjährlich, Pflegegrad 4 und 5 vierteljährlich. Bei Pflegegrad 1 ist er freiwillig. Wird er nicht abgerufen, kann das Pflegegeld gekürzt werden.

9 **A** Der Entlastungsbetrag steht allen Pflegebedürftigen in häuslicher Pflege zu, auch bei Pflegegrad 1. Er ist zweckgebunden (z. B. Betreuung, Haushaltshilfe, Tagespflege) und wird erstattet, nicht bar ausgezahlt.

10 **B** Tagespflege (§ 41 SGB XI) entlastet Angehörige tagsüber. Kurzzeitpflege (§ 42 SGB XI) überbrückt z. B. die Zeit nach einem Krankenhausaufenthalt oder eine Krise in der häuslichen Pflege.

11 **D** Nach § 40 SGB XI kann die Pflegekasse Umbauten bezuschussen, wenn sie die häusliche Pflege ermöglichen, erheblich erleichtern oder eine möglichst selbstständige Lebensführung wiederherstellen.

12 **C** Pflegekurse vermitteln Fertigkeiten wie Lagerung oder den Umgang mit Demenz und sollen Belastungen der Pflegenden mindern. Sie können auch in der Häuslichkeit stattfinden.

Strukturmodell & SIS

13 **A** Das Strukturmodell hat 4 Elemente: SIS (mit der Sicht der Person, 6 Themenfeldern und Risikomatrix), Maßnahmenplanung, Berichteblatt (nur Abweichungen) und Evaluation.

14 **C** Die Risikomatrix verknüpft die Themenfelder mit Risiken wie Dekubitus, Sturz, Inkontinenz, Schmerz und Ernährung. Bei Bedarf folgt eine vertiefte Einschätzung und eine Maßnahme.

15 **B** Im Strukturmodell gilt das Immer-so-Prinzip: Was geplant ist, wird nicht täglich einzeln abgezeichnet. Im Bericht stehen Abweichungen, Besonderheiten und Reaktionen.

Qualität & Heimrecht NRW

16 **C** Qualitätsprüfungen nach §§ 114 ff. SGB XI führen der Medizinische Dienst und der Prüfdienst der PKV durch. In NRW prüft zusätzlich die WTG-Behörde (Heimaufsicht) nach dem Wohn- und Teilhabegesetz.

17 **B**

Einrichtungen erheben halbjährlich Indikatoren zur Ergebnisqualität, z. B. Dekubitusentstehung, schwerwiegende Sturzfolgen oder unbeabsichtigter Gewichtsverlust. Der MD prüft die Plausibilität.

18 **B** Die Pflegevisite dient der Qualitätssicherung: Pflegeprozess, Wohlbefinden und Wünsche werden mit der Person (und ggf. Angehörigen) besprochen und die Planung angepasst.

19 **A** Seit der Föderalismusreform 2006 ist das Heimrecht Ländersache. In NRW gilt das WTG; zuständig sind die WTG-Behörden der Kreise und kreisfreien Städte.

Expertenstandards

20 **D** Das Deutsche Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege (DNQP) an der Hochschule Osnabrück entwickelt Expertenstandards, z. B. zu Dekubitus, Sturz, Schmerz, Ernährung, Kontinenz, chronischen Wunden und Demenz.

21 **B** Der Standard setzt auf eine individuelle Risikoeinschätzung statt starrer Skalen. Daraus folgen Maßnahmen wie Umgebungsanpassung, Kraft- und Balancetraining, Hilfsmittel und Information.

22 **A** Der Standard stellt die person-zentrierte Haltung in den Mittelpunkt. Pflegende erkennen Beziehungsbedürfnisse und gestalten Interaktionen bewusst, z. B. über Biografie und Validation.

23 **B** Bewegung beugt Sturz, Dekubitus, Kontrakturen und Pflegebedürftigkeit vor. Pflegende planen mobilitätsfördernde Maßnahmen individuell und beziehen Angehörige ein.

24 **C** Nach Einschätzung (Kontinenzprofil, Miktionsprotokoll) folgen Maßnahmen wie Toilettentraining, angepasste Kleidung, Hilfsmittel und Beckenbodentraining. Weniger zu trinken ist kontraproduktiv.

25 **B** Das Kontinenzprofil unterscheidet: Kontinenz, unabhängig erreichte Kontinenz, abhängig erreichte Kontinenz, unabhängig kompensierte, abhängig kompensierte und nicht kompensierte Inkontinenz.

Demenz & Delir

26 **C** Validation akzeptiert die innere Wirklichkeit des Menschen mit Demenz. Ziel sind Vertrauen, Sicherheit und Würde. Das tägliche Einüben von Fakten entspricht dem Realitätsorientierungstraining (ROT).

27 **A** Hinter dem Wunsch steckt oft ein Bedürfnis (Fürsorge, Sicherheit). Validierendes Eingehen und Biografiearbeit beruhigen meist besser als Konfrontation. Freiheitsentziehende Maßnahmen ohne Genehmigung sind unzulässig.

28 **C** Das NDB-Modell hilft, Ursachen zu suchen: Hintergrundfaktoren (z. B. Gesundheit, Persönlichkeit) und direkte Faktoren (z. B. Schmerz, Hunger, Lärm). Es wird im Expertenstandard Demenz empfohlen.

29 **C** Wer Schmerzen nicht mehr selbst angeben kann, wird fremd eingeschätzt, z. B. mit BESD/PAINAD (Atmung, Lautäußerung, Mimik, Körpersprache, Trost). Die NRS setzt Selbstauskunft voraus.

30 **B** Ein Delir ist ein akuter, oft reversibler Notfall (z. B. durch Infekt, Exsikkose, Medikamente). Es muss ärztlich abgeklärt werden – auch Menschen mit Demenz können zusätzlich ein Delir entwickeln.

Recht: FEM, Vorsorge, Verfügung

31 **B** Freiheitsentziehende Maßnahmen bei Einwilligungsunfähigen müssen vom rechtlichen Vertreter beantragt und vom Betreuungsgericht genehmigt werden (§ 1831 BGB). Ansätze wie der Werdenfelser Weg suchen Alternativen.

32 **A** Niedrigflurbetten, Sensormatten, Hüftprotektoren und gute Beleuchtung reduzieren Sturzfolgen ohne Freiheitsentzug. Gurte, Sedierung und Einschließen sind freiheitsentziehend.

33 **C** Mit Vorsorgevollmacht ist meist keine gerichtliche Betreuung nötig. Für freiheitsentziehende Maßnahmen braucht auch der Bevollmächtigte die Genehmigung des Betreuungsgerichts.

Geriatrie

34 **D** Weniger Durstempfinden, ein sinkender Wasseranteil, Angst vor Inkontinenz, Diuretika und Schluckprobleme begünstigen Flüssigkeitsmangel. Folgen: Verwirrtheit, Sturz, Obstipation, Nierenversagen.

35 **B** Stehende Hautfalten sind im Alter wenig aussagekräftig. Besser: Mundschleimhaut, Urinmenge und -farbe, akute Verwirrtheit, Blutdruckabfall, Gewichtsverlauf. Ödeme sprechen eher für Überwässerung.

36 **D** Als Faustregel gelten rund 30 ml/kg (meist um 1,5 l, die DGE nennt für Ältere etwa 1,3 l Getränke). Bei Herz- oder Niereninsuffizienz kann eine Trinkmengenbegrenzung angeordnet sein – diese hat Vorrang.

37 **B** Die PRISCUS-Liste (2023 aktualisiert als PRISCUS 2.0) nennt Wirkstoffe mit erhöhtem Risiko im Alter, z. B. bestimmte Benzodiazepine oder anticholinerge Medikamente, und Alternativen.

38 **C** Polypharmazie (meist ≥ 5 Dauermedikamente) erhöht das Risiko für Wechselwirkungen, Stürze und Verwirrtheit. Pflegende beobachten Nebenwirkungen und melden sie.

39 **C** Frailty zeigt sich u. a. durch Erschöpfung, Gewichtsverlust, Schwäche und langsame Gehgeschwindigkeit. Sie erhöht das Risiko für Stürze und Pflegebedürftigkeit; Bewegung und eiweißreiche Ernährung wirken vorbeugend.

40 **D** Belastungsinkontinenz entsteht durch einen geschwächten Verschlussmechanismus (häufig nach Geburten). Hilfreich: Beckenbodentraining. Dranginkontinenz: starker, plötzlicher Harndrang.

41 **D** Bei Überlaufinkontinenz ist der Abfluss behindert (z. B. Prostatavergrößerung); es droht ein Harnverhalt mit Rückstau. Restharn wird sonografisch bestimmt. Keine Trinkmengenreduktion!

42 **B** Obstipationsprophylaxe: Flüssigkeit, Ballaststoffe, Bewegung, feste Toilettenzeiten und Privatsphäre. Viele Medikamente (z. B. Opioide, Eisen) verstopfen – das gehört in die Beobachtung.

43 **D** Dysphagie birgt Aspirations- und Pneumoniegefahr. Bei Verdacht: aufrecht sitzen, kleine Bissen, Kostform anpassen, logopädische Abklärung veranlassen.

44 **C** Sarkopenie erhöht Sturz- und Frakturrisiko. Auch im hohen Alter verbessern Krafttraining und eiweißreiche Ernährung die Kraft messbar. Knochendichteverlust heißt Osteoporose.

Ernährung

45 **A** Der MNA (Kurzform MNA-SF) erfasst u. a. Appetit, Gewichtsverlust, Mobilität, akute Erkrankung, neuropsychologische Probleme und BMI bzw. Wadenumfang.

46 **B** Unbeabsichtigter Gewichtsverlust (> 5 % in 3 Monaten bzw. > 10 % in 6 Monaten) ist ein zentrales Warnsignal. Gewicht regelmäßig kontrollieren und dokumentieren.

47 **C** Fingerfood und 'Eat by walking' erhalten Selbstständigkeit und sichern die Nahrungsaufnahme. Fixieren ist freiheitsentziehend; Trinknahrung ergänzt, ersetzt aber nicht Essen in Gemeinschaft.

48 **D** Die Leitlinien (u. a. DGEM, S3 Demenzen) raten bei fortgeschrittener Demenz von routinemäßiger Sondenernährung ab, weil Überleben und Lebensqualität meist nicht verbessert werden. Entscheidend sind Indikation und (mutmaßlicher) Wille.

Haut & Dekubitus

49 **A** Kategorie 1 = nicht wegdrückbare Rötung bei intakter Haut (Fingertest). Kategorie 2 = Teilverlust der Haut, z. B. Blase oder flache offene Wunde. Ab Kategorie 3 sind tiefere Schichten betroffen.

50 **D** IAD entsteht durch Urin/Stuhl auf der Haut und ist nicht an einen Knochenvorsprung gebunden. Hilfreich: schonende, pH-hautneutrale Reinigung, Hautschutz, rasch wechseln. Die Abgrenzung zum Dekubitus ist wichtig für die Dokumentation.

51 **A** Altershaut ist dünner und trockener. Rückfettung schützt die Hautbarriere. Franzbranntwein und Alkohol trocknen aus; Puder kann verklumpen und reizen.

Palliativ & Sterbephase

52 **D** SAPV (§ 37b SGB V) wird ärztlich verordnet. Ein Palliativteam aus Ärzten und Pflegefachkräften ist rund um die Uhr erreichbar und ermöglicht das Sterben zu Hause bzw. in der Einrichtung.

53 **A** In der Finalphase ziehen sich Menschen zurück und essen und trinken kaum. Rasselatmung entsteht durch Sekret im Rachen; Absaugen belastet meist mehr als es hilft – Lagerung und ärztlich angeordnete Medikamente stehen im Vordergrund.

54 **A** Durstgefühl in der Sterbephase hängt vor allem von der Mundtrockenheit ab. Mundpflege mit Vertrautem (z. B. Saft, Bier, Kaffee) lindert. Infusionen verstärken oft Ödeme und Rasselatmung; Zitronenglycerin trocknet nach kurzer Wirkung weiter aus.

55 **A** Palliative Care umfasst Symptomlinderung (Schmerz, Atemnot, Übelkeit), psychosoziale und spirituelle Begleitung sowie Unterstützung der Angehörigen.

Ambulante Pflege

56 **A** Erst die Situation sichern und nach ABCDE einschätzen. Bei Bewusstlosigkeit, Kopfverletzung unter Antikoagulation, Verdacht auf Fraktur oder Unfähigkeit aufzustehen: Notruf 112. Danach dokumentieren und Ursachen klären.

57 **D** Der Hausnotruf kann als Pflegehilfsmittel von der Pflegekasse bezuschusst werden. Der Funkfinger sollte immer getragen werden – auch im Bad.

58 **C** Die 5 Momente der Händehygiene gelten auch zu Hause. Pflegedienste stellen eigene Desinfektionsmittel und Schutzausrüstung; Handschuhe nach jeder Tätigkeit wechseln.

59 **A** Medikamentengabe ist Behandlungspflege und muss verordnet sein. Beim Teilen oder Mörsern prüfen, ob das Präparat dafür geeignet ist (z. B. keine Retardtabletten mörsern).

60 **C** Das Selbstbestimmungsrecht gilt auch in der Pflege. Ablehnungen werden dokumentiert; bei Gefährdung (z. B. Hautschäden) wird mit Arzt, Angehörigen und Leitung nach Lösungen gesucht.

61 **B** Überlastung gefährdet Angehörige und Pflegebedürftige. Pflegende informieren über Entlastung: Pflegekurse, Tages- oder Verhinderungspflege, Entlastungsbetrag und Pflegeberatung (§ 7a SGB XI).

62 **D** Bei Verdacht auf Gewalt gegen Ältere zählen sachliche Dokumentation (Lage, Größe, Farbe, Aussagen wörtlich) und das Vorgehen nach internem Konzept. Ansprechpartner sind auch Hausarzt und Beratungsstellen.

Mobilität

63 **A** Kinästhetik setzt auf gemeinsame Bewegung, Gewichtsverlagerung und die Ressourcen der Person. Das schont auch den Rücken der Pflegenden.

64 **C** Der Achselgriff gefährdet die Schultergelenke, Ziehen am Laken erzeugt Scherkräfte. Hilfsmittel und Kinästhetik reduzieren Belastung und Verletzungsrisiko.

65 **A** Kontrakturprophylaxe: regelmäßige Bewegung (aktiv, assistiv, passiv), physiologische Lagerung und Mobilisation. Häufig betroffen: Spitzfuß, Hüft- und Kniebeugekontraktur.

Kommunikation & Ethik

66 **D** Blickkontakt erleichtert das Lippenlesen, Schreien verzerrt die Sprache. Hörgeräte prüfen (Batterie, eingesetzt?). Kurze, klare Sätze helfen; Schriftliches kann ergänzen.

67 **B** Elderspeak ist eine Babysprache gegenüber Älteren ('Na, haben wir schon gegessen?'). Sie wirkt bevormundend und kann Widerstand fördern. Respektvolle Erwachsenenkommunikation fördert Kooperation.

68 **C** Ethische Fallbesprechungen (z. B. Nimwegener Methode) beziehen alle Beteiligten ein und strukturieren schwierige Entscheidungen, etwa zu Ernährung am Lebensende oder Krankenhauseinweisung.

Hygiene

69 **C** Die KRINKO empfiehlt für Heime eine Risikoabwägung: Soziale Teilhabe bleibt möglich, wenn z. B. Wunden abgedeckt sind. Zentral ist die Händehygiene.

70 **B** Noroviren sind hochansteckend. Maßnahmen: Händewaschen plus viruzide Desinfektion, Schutzausrüstung, Isolierung bzw. Kohortierung, Information von Leitung und Gesundheitsamt (gehäuftes Auftreten ist meldepflichtig).

71 **B** Die STIKO empfiehlt Menschen ab 60 und Bewohnern von Pflegeeinrichtungen die jährliche Influenzaimpfung, außerdem u. a. Pneumokokken, COVID-19-Auffrischung und RSV nach Empfehlung. Tetanus wird alle 10 Jahre aufgefrischt.

Fallbeispiele

72 **C** Akute Verwirrtheit ist ein Warnsignal (Delir). Exsikkose, Harnwegsinfekt oder Medikamente sind häufige Ursachen. Schnelle ärztliche Abklärung verhindert Krankenhausaufenthalte.

73 **A** Nach Expertenstandard: individuelle Risikofaktoren (Nykturie, Medikamente, Umgebung) erkennen und gezielt angehen. Bettgitter ohne Genehmigung sind freiheitsentziehend und erhöhen die Sturzhöhe.

74 **B** Bei fortgeschrittener Demenz ist eine PEG medizinisch meist nicht vorteilhaft. Entscheidend ist der Wille der Person (Patientenverfügung, frühere Äußerungen). Pflege bietet Lieblingsspeisen, Fingerfood und Mundpflege an.

75 **D** Bei Diabetes fehlt durch Neuropathie oft das Schmerzempfinden. Nekrosen und Druckstellen müssen schnell ärztlich beurteilt werden (diabetisches Fußsyndrom). Fußbäder können zu Verbrennungen und Mazeration führen.

76 **A** Pflegende Angehörige sind die größte Säule der häuslichen Versorgung. Frühe Entlastung verhindert Krisen: Tages- und Verhinderungspflege, Entlastungsbetrag, Pflegekurse, Pflegeberatung (§ 7a SGB XI) und Pflegestützpunkte.

77 **B** Parkinson-Medikamente wirken zeitkritisch. Eiweißreiche Mahlzeiten vermindern die Aufnahme von L-Dopa; die Einnahme erfolgt meist 30 Minuten vor oder 60–90 Minuten nach dem Essen. Dosisänderungen nur ärztlich.

Bestehen ist planbar. Mit der PLAN-App.
Prüfungsfragen mit Erklärungen, Krankheitsbilder, Pflegeplanung und KI-Lernhilfe – kostenlos auf **plan-nrw.de**

© PLAN Digital · Patrick Schenkelberger. Nur für den persönlichen Gebrauch. Weitergabe, Weiterverkauf und Veröffentlichung nicht gestattet.